# EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 85199
SERVICIO : AREA QUIRÚRGICA HSC
FECHA : 2024-05-24 12:55:00

## DATOS DEL PACIENTE:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | : JUAN DE DIOS FLORES TORRES | | | RUN | : 5.249.221-1 |
| F.Nac | : 18-11-1944 | Edad | : 79 AÑOS, 6 MESES | Género | : Masculino |
| Dirección | : EL SAUCE | | | Comuna | : SAN CARLOS |
| Previsión | : PRAIS | Teléfono | : 956812010 | | |
| Fecha Ingreso | : 13-05-2024 | Fecha Egreso | : 2024-05-24 12:55:00 | Causal | : MEDICA |
| Condición | : VIVO | Destino | : DOMICILIO | Derivación | : |

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. M87.9-OSTEONECROSIS, NO ESPECIFICADA

## DIAGNOSTICO(S) EGRESO

PIE DIABETICO
DM IR
HTA
ARTROSIS
AMPUTACION TMT DERECHA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. M86.4-OSTEOMIELITIS CRONICA CON DRENAJE DEL SENO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

## COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE CONSULTO EL DIA 13/5/24 POR MALA EVOLUCION DE PIE DIABETICO SE EVIDENCIA ERITEMA EN BORDE EXTERNO DE PIE, AL EXAMEN FISICO SE EVIDENCIA CREPITACION LOCAL Y SIGNOS DE FRACTURA DE EXTREMO DISTAL METATARCIANO.
LABORATORIO IMPRESIONA AUMENTO DE PARAMETROS INFLAMATORIOS, RX DE PIE EVIDENCIA FRACTURA Y OSTEOMIELITIS DE 5° Y 2° ORTEJO, SE DECIDIO AMPUTACION INFRACONDILIA DEFINITIVA SIN EMBARGO SE PLANTEA AMPUITACION INICAL TRANSMETATARSIANA PARA EVALUAR EVOLUCION Y DEFINIR CONDUCTA.
SE HOSPITALIZA Y SE REALIZA AMPUTACION TMT EL 17/05/24, HALLAZGOS EN PABELLON DE MUÑON INFECTADO, OSTEOMIELITIS DE 2° Y 5° ORTEJO. AMPUTACION SE REALIZÓ SIN INCIDENTES.
PACIENTE CON BUENA EVOLUCION POSTERIOR, SE EVIDENCIA TEMBLOR EN REPOSO, SE SOLICITO EVALUACION POR NEUROLOGIA AUN PENDIENTE
PACIENTE EN BEG, TRANQUILO, HEMODINAMIA ESTABLE, SIN APREMIO VENTILATORIO, AFEBRIL, TOLERANDO REGIMEN, DIUERIS + DEPOSICIONES +

EX FISICO:
ALERTA, VIGIL, OTE, PIEL ROSADA, MUCOSA HIDRATADAS, LLENE CAPILAR <2S.
HERIDA CUBIERTA, HOY NO TOCA DESCUBRIR, APOSITOS LIMPIOS Y SECOS. HERIDA EVUALUADA POR FOTOGRAFIA DE AYER, HERIDA EN BUENAS CONDICIONES LECHO VITAL, SIN SANGRADO ACTIVO, SIN SIGNOS DE INFECCION NI NECROSIS.

## PLAN DE MANEJO:

COMPLETAR TRATAMIENTO ANTIBIOTICO
KNT MOTORA POR HODOM
CURACIONES POR HODOM C/48 HRS

CONTROL EN CAE DE CIRUGIA EN 15 DIAS
CONTROL CON NEUROLOGIA POR TEMBROL EN POLICLINICO
CONSULTAR EN URGENCIA SOS

## INDICACIONES AL ALTA

1. REPOSO RELATIVO
2. REGIMEN LIVIANO HIPOSODICO, DIABETICO
3. AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO COMPRIMIDO 875 MILÍGRAMOS / 125 MILÍGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 7 dias via ORAL
4. OMEPRAZOL COMPRIMIDO 20 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 15 dias via ORAL
5. INSULINA NPH CARTRIDGE (PENFILL) 100 UI/ML X 3 ML UNIDAD UNIDAD 12 UI AM 6 UI PM
6. LOSARTAN POTASICO COMPRIMIDO 50 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
7. BISOPROLOL COMPRIMIDO 2,5 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
8. ATORVASTATINA COMPRIMIDO 40 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
9. CLOPIDROGEL COMPRIMIDO 75 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
10. KNT MOTORA POR HODOM
11. CURACIONES POR HODOM C/48 HRS
12. CONTROL EN CAE DE CIRUGIA EN 15 DIAS
13. CONSULTAR EN URGENCIA SOS

Control en: 15 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

NICOLÁS JAIME LETELIER ALARCÓN
MEDICO TRATANTE
17757150-4

JEFE SERVICIO